グラム染色所見とコロニー性状の乖離から二形性真菌を疑ったヒストプラズマ症の一例

◎森本 晃平[1)]、杉江 和茂[1)]、関口 敬文[1)]、森田 未香[1)]、横田 綾[1)]、村井 佑至[2)]、山本 善裕[2)]
富山大学附属病院 検査・輸血細胞治療部[1)]、富山大学附属病院 感染症科[2)]

【はじめに】Histoplasma capsulatum は二形性真菌であり、自然環境では菌糸形、宿主内では酵母形を示す。土壌やコウモリ・鳥の糞中に広く分布し、分生子の吸入による経気道感染が主な感染経路である。流行地は熱帯・亜熱帯地域であり、本邦では主に輸入真菌症として遭遇する。今回、検査過程において二形性真菌を疑い対応した播種性ヒストプラズマ症の一例を経験したため報告する。

【症例】外国籍の 49 歳男性。前額部のびらん・紅斑を主訴に近医皮膚科を受診し、細菌感染を疑われ抗菌薬含有軟膏およびテトラサイクリン系抗菌薬を投与されたが改善なく、潰瘍が出現したため 20XX 年 1 月 26 日に当院皮膚科を紹介受診した。皮膚検体の培養にて二形性真菌が疑われ、2 月 14 日の感染症科紹介時に HIV スクリーニング陽性が判明した。2 月 16 日には発熱および胸部不快感を認め、上部消化管内視鏡検査で食道カンジダ症と診断され、L-AMB 投与が開始された。その後、皮膚およびリンパ節検体より発育した菌が H. capsulatum と同定され、播種性ヒストプラズマ症と確定診断された。

【微生物学検査】皮膚検体のグラム染色にて酵母様真菌を認め、当初はマラセチア属を鑑別に挙げた。しかし、血液寒天培地上に糸状菌様コロニーが発育したため、ラクトフェノールコットンブルー染色を実施し糸状菌形態を確認した。これらの所見から輸入真菌症（二形性真菌）を疑い、速やかに主治医へ報告した。以降、検査室内感染のリスクを考慮し培地は密封管理とし、菌種同定は国立感染症研究所および千葉大学へ依頼した。前額部皮膚および後頚部リンパ節から H. capsulatum が分離され、尿中抗原も陽性であったことから播種性ヒストプラズマ症と診断された。

【考察】輸入真菌症の原因菌は BSL3 に分類され、通常の検査室での取り扱いには十分な注意が必要である。本症例では、グラム染色所見とコロニー性状の乖離に着目し、二形性真菌を疑うことができたため、その後の検査室内の感染対策を適切に行うことができた。国内で診断される二形性真菌症の多くは輸入例であり、患者の国籍や渡航歴の確認が診断の一助となる。<連絡先：076-434-2315>